JEU DE 32 CARTES + 2 JOKERS · ÉTUDIANTS IPA, NIVEAU MASTER

# Théories de soins infirmiers

Un jeu de 32 cartes classique dont chaque couleur correspond à une étape de mobilisation d'une théorie de soins et chaque valeur à une théoricienne, travaillée à partir d'un cas clinique. Les valeurs suivent l'ordre chronologique des théories, de Peplau (1952) à Meleis (2010). Réunir les quatre cartes d'une valeur, c'est passer de la théorie à la pratique.

## Les 4 couleurs = 4 étapes

| | |
|---|---|
| ♥ | **Cœur — Comprendre la théorie**<br>Auteure, concepts clés, vision du soin |
| ♦ | **Carreau — Recueillir avec le modèle**<br>Ce que la théorie invite à observer chez la personne |
| ♣ | **Trèfle — Analyser la situation**<br>Formuler la situation dans le langage de la théorie |
| ♠ | **Pique — Intervenir & évaluer**<br>Interventions et critères d'évaluation issus du modèle |

## Les 8 valeurs = 8 théories

| | |
|---|---|
| **7** | Hildegard Peplau · 1952 |
| **8** | Virginia Henderson · 1960-1966 |
| **9** | Dorothea Orem · 1959-1971 |
| **10** | Callista Roy · 1970 |
| **V** | Moyra Allen · années 1970-1980 |
| **D** | Nola Pender · 1982 |
| **R** | Katharine Kolcaba · années 1990 |
| **A** | Afaf Meleis · 2000-2010 |

## Anatomie d'une carte

**Vignette** (situation du patient, qui évolue d'une couleur à l'autre) · **Question** posée au joueur · **Repères attendus**, lus uniquement par celui qui pose la question pour valider la réponse. Les repères ne sont pas exhaustifs : une argumentation pertinente non listée est valorisée.

## Mode 1 · Le Carré clinique

*3 à 6 joueurs · 45 à 60 min*

1. Distribuer 5 cartes par joueur ; le reste forme la pioche.
2. À son tour, un joueur demande à un autre une carte précise pour avancer un carré (« le Trèfle de Neuman »).
3. Si l'autre la possède, il lit la vignette et la question ; le demandeur répond. Réponse validée au regard des repères → il prend la carte et rejoue. Sinon, ou si la carte n'est pas en jeu, il pioche et la main passe.
4. Carré complet : le joueur le pose et présente en 2 minutes une **synthèse orale** du raisonnement (recueil → hypothèses → vérification → action) : **4 points**. +1 point s'il le relie à une autre thématique (Orem et Henderson, Pender et Kolcaba…).
5. Fin de partie quand la pioche est vide : le plus de points l'emporte.

### Les jokers

**Métaparadigme** et **Changement de lunettes** remplacent une carte manquante d'un carré, à condition de relever le défi inscrit dessus.

## Mode 2 · Le Fil rouge

*Travaux dirigés · groupes de 4 à 8 · 20 min par cas*

L'animateur extrait les 4 cartes d'une théorie et les révèle dans l'ordre ♥ ♦ ♣ ♠. Le groupe raisonne à voix haute à chaque étape avant de découvrir la suivante, puis compare avec les repères.

## Mode 3 · Le Tirage éclair

*Révision en binôme · 10 à 15 min*

Mélanger, tirer une carte, lire la vignette et la question ; le partenaire répond en 1 minute. Comparer aux repères, puis inverser les rôles.

### Pistes de débriefing

- Ce que la théorie fait voir… et ce qu'elle laisse dans l'ombre
- Comparer deux théories sur un même cas
- Grande théorie, modèle conceptuel ou théorie intermédiaire ?
- Utilité pour la pratique avancée : parcours, ETP, coordination

**Impression :** A4, recto verso (retournement bord long), échelle 100 %, papier 250 à 300 g/m² ; découper le long des repères de coupe. Pages impaires = faces, pages paires = dos.
**Avertissement :** contenus fondés sur les écrits des théoriciennes et la littérature de référence en sciences infirmières, tels que connus en octobre 2026 ; les données cliniques des cas sont illustratives. Ils sont à vérifier et à adapter par l'équipe pédagogique avant usage.

7 ♥

♥ CŒUR · COMPRENDRE LA THÉORIE

## Hildegard Peplau

Relations interpersonnelles · 1952

> *M. J., 28 ans, est suivi en CMP par une IPA après un premier épisode psychotique. Méfiant, il parle peu.*

### ? Quels sont les concepts clés de la théorie de Peplau ?

REPÈRES ATTENDUS

- La relation infirmière-patient est en elle-même un processus thérapeutique
- Quatre phases : orientation, identification, exploitation, résolution
- Rôles infirmiers : inconnue, personne-ressource, enseignante, leader, substitut, conseillère
- L'anxiété, selon son niveau, mobilise ou bloque l'apprentissage

Théories de soins infirmiers · IPA

7 ♥

7 ♦

♦ CARREAU · RECUEILLIR AVEC LE MODÈLE

## Hildegard Peplau

Relations interpersonnelles · 1952

**Situation :** M. J., 28 ans, est suivi en CMP par une IPA après un premier épisode psychotique. Méfiant, il parle peu.

> *Il arrive en retard, regarde la porte et répond par monosyllabes.*

### ? Quelles données recueillez-vous au regard de ce modèle ?

REPÈRES ATTENDUS

- Niveau d'anxiété et ses manifestations
- Perception qu'il a de sa situation et de ses besoins
- Attentes vis-à-vis de l'IPA, représentation du soin
- Expériences relationnelles antérieures avec les soignants
- Vos propres réactions dans la relation (contre-attitudes)

Théories de soins infirmiers · IPA

7 ♦

7 ♣

♣ TRÈFLE · ANALYSER LA SITUATION

## Hildegard Peplau

Relations interpersonnelles · 1952

**Situation :** M. J., 28 ans, est suivi en CMP par une IPA après un premier épisode psychotique. Méfiant, il parle peu.

> *Après trois rencontres, il ne sait toujours pas « à quoi sert » le suivi.*

### ? Comment formulez-vous la situation selon Peplau ?

REPÈRES ATTENDUS

- Phase d'orientation non achevée : le problème et le cadre ne sont pas clarifiés
- L'IPA reste dans le rôle d'« inconnue »
- Méfiance et anxiété élevée limitent la capacité d'apprentissage
- Préalable : construire la sécurité relationnelle avant tout projet éducatif

Théories de soins infirmiers · IPA

7 ♣

7 ♠

♠ PIQUE · INTERVENIR & ÉVALUER

## Hildegard Peplau

Relations interpersonnelles · 1952

**Situation :** M. J., 28 ans, est suivi en CMP par une IPA après un premier épisode psychotique. Méfiant, il parle peu.

> *Il commence à évoquer ses voix et sa peur de « redevenir fou ».*

### ? Quelles interventions et quels critères d'évaluation retenez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Cadre stable : même soignante, même horaire, contrat clair
- Écoute active, reformulation, clarification de ses besoins
- Accompagner vers l'exploitation : il utilise les ressources (ETP, CMP, pairs aidants)
- Préparer la résolution dès le début : autonomie, fin anticipée du suivi
- Évaluation : il formule ses besoins et s'engage dans le suivi

Théories de soins infirmiers · IPA

7 ♠

♥ ♦ ♣ ♠

**Théories de soins**

CAS CLINIQUES

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

**Théories de soins**

CAS CLINIQUES

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

**Théories de soins**

CAS CLINIQUES

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

**Théories de soins**

CAS CLINIQUES

IPA · Master

8 ♥

♥ CŒUR · COMPRENDRE LA THÉORIE

## Virginia Henderson

Les 14 besoins fondamentaux · 1960-1966

> *Mme H., 79 ans, rentre à domicile après un AVC avec hémiparésie gauche légère. Elle vit seule.*

### ? Quelles sont les idées clés du modèle de Henderson ?

REPÈRES ATTENDUS

- 14 besoins fondamentaux, de « respirer » à « apprendre »
- Chaque besoin s'évalue en termes d'indépendance ou de dépendance
- Sources de difficulté : manque de force, de volonté ou de connaissance
- Rôle infirmier : suppléer et aider la personne à retrouver son indépendance le plus vite possible

Théories de soins infirmiers · IPA

♥ 8

8 ♦

♦ CARREAU · RECUEILLIR AVEC LE MODÈLE

## Virginia Henderson

Les 14 besoins fondamentaux · 1960-1966

**Situation :** Mme H., 79 ans, rentre à domicile après un AVC avec hémiparésie gauche légère. Elle vit seule.

> *Elle marche avec une canne, peine à s'habiller et dit « ne plus servir à rien ».*

### ? Comment organisez-vous le recueil de données ?

REPÈRES ATTENDUS

- Passage en revue des 14 besoins : manifestations d'indépendance et de dépendance
- Se mouvoir, se vêtir, être propre, éliminer, éviter les dangers (chutes)
- Communiquer, s'occuper en vue de se réaliser, se récréer
- Apprendre : connaissances sur l'AVC et les aides possibles
- Ressources : entourage, aides à domicile, logement

Théories de soins infirmiers · IPA

♦ 8

8 ♣

♣ TRÈFLE · ANALYSER LA SITUATION

## Virginia Henderson

Les 14 besoins fondamentaux · 1960-1966

**Situation :** Mme H., 79 ans, rentre à domicile après un AVC avec hémiparésie gauche légère. Elle vit seule.

> *Elle a chuté une fois dans la salle de bains et sort de moins en moins.*

### ? Comment analysez-vous la situation avec ce modèle ?

REPÈRES ATTENDUS

- Besoins perturbés à hiérarchiser : éviter les dangers, se mouvoir, être propre
- Source de difficulté identifiée pour chacun : force (hémiparésie), connaissance, volonté (découragement)
- Besoins interdépendants : la peur de chuter réduit la mobilité et l'occupation
- Limite du modèle : risque de fragmenter la personne en besoins

Théories de soins infirmiers · IPA

♣ 8

8 ♠

♠ PIQUE · INTERVENIR & ÉVALUER

## Virginia Henderson

Les 14 besoins fondamentaux · 1960-1966

**Situation :** Mme H., 79 ans, rentre à domicile après un AVC avec hémiparésie gauche légère. Elle vit seule.

> *Mme H. souhaite rester chez elle.*

### ? Quelles interventions et quels critères d'évaluation proposez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Suppléance partielle et temporaire (aide à la toilette), à réduire progressivement
- Stimuler l'indépendance : kinésithérapie, ergothérapie, aménagement de la salle de bains
- Enseignement : prévention des chutes, signes d'alerte d'AVC
- Restaurer l'occupation et la récréation : activités, liens sociaux
- Évaluation : niveau d'indépendance par besoin, au fil du temps

Théories de soins infirmiers · IPA

♠ 8

♥ ♦ ♣ ♠

**Théories de soins**

CAS CLINIQUES

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

**Théories de soins**

CAS CLINIQUES

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

**Théories de soins**

CAS CLINIQUES

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

**Théories de soins**

CAS CLINIQUES

IPA · Master

9 ♥

♥ CŒUR · COMPRENDRE LA THÉORIE

## Dorothea Orem

Déficit d'auto-soin · 1959-1971

> *M. O., 66 ans, insuffisant cardiaque, a été réhospitalisé deux fois en six mois. Il est suivi par une IPA.*

### ? Quelles sont les trois théories qui composent le modèle d'Orem ?

REPÈRES ATTENDUS

- Théorie de l'auto-soin : actions que la personne accomplit pour maintenir vie, santé et bien-être
- Théorie du déficit d'auto-soin : la demande dépasse la capacité d'auto-soin
- Théorie des systèmes infirmiers : entièrement compensatoire, partiellement compensatoire, soutien-éducation
- Exigences d'auto-soin universelles, liées au développement, liées à un écart de santé



♥ 6

9 ♦

♦ CARREAU · RECUEILLIR AVEC LE MODÈLE

## Dorothea Orem

Déficit d'auto-soin · 1959-1971

**Situation :** M. O., 66 ans, insuffisant cardiaque, a été réhospitalisé deux fois en six mois. Il est suivi par une IPA.

> *Il ne se pèse jamais et ne fait pas le lien entre son essoufflement et ses écarts de sel.*

### ? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Exigences universelles : alimentation, hydratation, activité-repos
- Exigences de développement : retraite récente, changement de rôle
- Exigences liées à l'écart de santé : régime peu salé, pesée, traitements, signes d'alerte
- Capacités d'auto-soin : connaissances, motivation, capacités physiques et cognitives
- Facteurs conditionnants : âge, famille, ressources, système de santé



♦ 6

9 ♣

♣ TRÈFLE · ANALYSER LA SITUATION

## Dorothea Orem

Déficit d'auto-soin · 1959-1971

**Situation :** M. O., 66 ans, insuffisant cardiaque, a été réhospitalisé deux fois en six mois. Il est suivi par une IPA.

> *Ses capacités physiques et cognitives sont préservées ; son épouse est très présente.*

### ? Comment formulez-vous la situation selon Orem ?

REPÈRES ATTENDUS

- Déficit d'auto-soin lié à l'écart de santé : surveillance et régime non assurés
- Cause principale : connaissances insuffisantes, et non incapacité
- Système infirmier indiqué : soutien-éducation
- Ressource : l'épouse peut être agent d'auto-soin associé



♣ 6

9 ♠

♠ PIQUE · INTERVENIR & ÉVALUER

## Dorothea Orem

Déficit d'auto-soin · 1959-1971

**Situation :** M. O., 66 ans, insuffisant cardiaque, a été réhospitalisé deux fois en six mois. Il est suivi par une IPA.

> *M. O. accepte un suivi rapproché.*

### ? Quelles interventions et quels critères d'évaluation retenez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Éducation thérapeutique : pesée quotidienne, régime peu salé, traitements
- Signes d'alerte et conduite à tenir (prise de poids rapide, œdèmes, dyspnée)
- Outils : carnet de suivi, télésurveillance selon le dispositif local
- Associer l'épouse sans se substituer à lui
- Évaluation : autonomie dans l'auto-surveillance, réhospitalisations évitées



♠ 6

♥ ♦ ♣ ♠

**Théories de soins**

CAS CLINIQUES

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

**Théories de soins**

CAS CLINIQUES

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

**Théories de soins**

CAS CLINIQUES

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

**Théories de soins**

CAS CLINIQUES

IPA · Master

10 ♥

♥ CŒUR · COMPRENDRE LA THÉORIE

## Callista Roy

Modèle de l'adaptation · 1970

> *Mme R., 47 ans, mère de deux adolescents, est en chimiothérapie après une mastectomie pour cancer du sein.*

### ? Quels sont les concepts clés du modèle de Roy ?

REPÈRES ATTENDUS

- La personne est un système adaptatif soumis à des stimuli
- Stimuli focal, contextuels et résiduels
- Mécanismes d'adaptation : régulateur (physiologique) et cognateur (cognitif, émotionnel)
- Quatre modes : physiologique, concept de soi, fonction de rôle, interdépendance
- Réponses adaptatives ou inefficaces ; soin = promouvoir l'adaptation



10 ♦

♦ CARREAU · RECUEILLIR AVEC LE MODÈLE

## Callista Roy

Modèle de l'adaptation · 1970

**Situation :** Mme R., 47 ans, mère de deux adolescents, est en chimiothérapie après une mastectomie pour cancer du sein.

> *Elle évite les miroirs, a cessé de travailler et se replie sur elle-même.*

### ? Que recueillez-vous selon les quatre modes d'adaptation ?

REPÈRES ATTENDUS

- Physiologique : fatigue, nausées, douleur, sommeil
- Concept de soi : image corporelle, estime de soi, féminité
- Fonction de rôle : arrêt de travail, rôle de mère et de conjointe
- Interdépendance : relation avec le conjoint, soutien, repli
- Pour chaque comportement : adaptatif ou inefficace ?



10 ♣

♣ TRÈFLE · ANALYSER LA SITUATION

## Callista Roy

Modèle de l'adaptation · 1970

**Situation :** Mme R., 47 ans, mère de deux adolescents, est en chimiothérapie après une mastectomie pour cancer du sein.

> *« Je ne me reconnais plus. Mon mari ne me regarde plus de la même façon. »*

### ? Comment analysez-vous les stimuli en jeu ?

REPÈRES ATTENDUS

- Stimulus focal : mastectomie et alopécie
- Stimuli contextuels : fatigue de la chimiothérapie, regard perçu du conjoint, arrêt de travail
- Stimuli résiduels : croyances sur la féminité, expériences antérieures
- Réponse inefficace prioritaire dans le mode concept de soi



10 ♠

♠ PIQUE · INTERVENIR & ÉVALUER

## Callista Roy

Modèle de l'adaptation · 1970

**Situation :** Mme R., 47 ans, mère de deux adolescents, est en chimiothérapie après une mastectomie pour cancer du sein.

> *Mme R. accepte d'en parler avec son mari et vous.*

### ? Quelles interventions et quels critères d'évaluation proposez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Agir sur les stimuli : information sur prothèse et reconstruction, gestion de la fatigue
- Soins de support : socio-esthétique, psychologue, activité physique adaptée
- Associer le conjoint ; groupes de pairs
- Préparer la reprise progressive du travail
- Évaluation : comportements adaptatifs (regard sur soi, reprise d'activités, liens)

♥ ♦ ♣ ♠

**Théories de soins**

CAS CLINIQUES

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

**Théories de soins**

CAS CLINIQUES

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

**Théories de soins**

CAS CLINIQUES

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

**Théories de soins**

CAS CLINIQUES

IPA · Master

V ♥

♥ CŒUR · COMPRENDRE LA THÉORIE

## Moyra Allen

Modèle de McGill · années 1970-1980

> *M. L., 76 ans, a une maladie de Parkinson évoluée. Son épouse, 74 ans, assure seule son accompagnement.*

### ? Quels sont les concepts clés du modèle de McGill ?

**REPÈRES ATTENDUS**

- La santé s'apprend, surtout au sein de la famille
- La famille est l'unité de soin
- Santé = processus de coping et de développement, qui coexiste avec la maladie
- Partenariat collaboratif ; l'infirmière s'appuie sur les forces de la famille



V ♦

♦ CARREAU · RECUEILLIR AVEC LE MODÈLE

## Moyra Allen

Modèle de McGill · années 1970-1980

**Situation :** M. L., 76 ans, a une maladie de Parkinson évoluée. Son épouse, 74 ans, assure seule son accompagnement.

> *Mme L. dit être « à bout », mais refuse toute aide extérieure.*

### ? Quelles données recueillez-vous ?

**REPÈRES ATTENDUS**

- Perception de la situation par chacun des membres de la famille
- Forces : savoirs acquis, humour, réseau, histoire du couple
- Façons de faire face (coping) et ce qui a déjà fonctionné
- Objectifs de santé que se fixe la famille
- Tâches de développement : vieillissement, transformation du couple



V ♣

♣ TRÈFLE · ANALYSER LA SITUATION

## Moyra Allen

Modèle de McGill · années 1970-1980

**Situation :** M. L., 76 ans, a une maladie de Parkinson évoluée. Son épouse, 74 ans, assure seule son accompagnement.

> *Elle veut « bien faire » et craint d'être jugée si elle délègue.*

### ? Comment formulez-vous la situation selon ce modèle ?

**REPÈRES ATTENDUS**

- Situation d'apprentissage : la famille apprend à vivre avec une maladie évolutive
- Forces présentes mais sous-utilisées ; coping centré sur l'effort seul
- Objectif prioritaire défini par la famille : préserver la santé de l'aidante
- Le refus d'aide a un sens, à explorer plutôt qu'à contourner



V ♠

♠ PIQUE · INTERVENIR & ÉVALUER

## Moyra Allen

Modèle de McGill · années 1970-1980

**Situation :** M. L., 76 ans, a une maladie de Parkinson évoluée. Son épouse, 74 ans, assure seule son accompagnement.

> *Le couple accepte de « réfléchir ensemble » à des solutions.*

### ? Quelles interventions et quels critères d'évaluation proposez-vous ?

**REPÈRES ATTENDUS**

- Co-construire les objectifs à partir des priorités du couple
- Valoriser les compétences de l'aidante
- Favoriser l'apprentissage par essais : un accueil de jour à l'essai, par exemple
- Mobiliser le réseau : plateforme de répit, aides à domicile, associations
- Évaluation : sentiment de compétence, fardeau de l'aidante (échelle de Zarit)

♥ ♦ ♣ ♠

**Théories de soins**

CAS CLINIQUES

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

**Théories de soins**

CAS CLINIQUES

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

**Théories de soins**

CAS CLINIQUES

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

**Théories de soins**

CAS CLINIQUES

IPA · Master

D ♥

♥ CŒUR · COMPRENDRE LA THÉORIE

## Nola Pender

Promotion de la santé · 1982

> *Mme P., 50 ans, sédentaire, prédiabétique, voudrait « se remettre au sport » sans y parvenir.*

### ? Quels sont les concepts clés du modèle de Pender ?

REPÈRES ATTENDUS

- Caractéristiques et expériences individuelles : comportements antérieurs, facteurs personnels
- Bénéfices perçus, obstacles perçus, auto-efficacité perçue
- Affects liés à l'activité ; influences interpersonnelles et situationnelles
- Engagement dans un plan d'action, face à des exigences concurrentes
- Résultat : comportement de promotion de la santé



D ♥

D ♦

♦ CARREAU · RECUEILLIR AVEC LE MODÈLE

## Nola Pender

Promotion de la santé · 1982

**Situation :** Mme P., 50 ans, sédentaire, prédiabétique, voudrait « se remettre au sport » sans y parvenir.

> *Elle adorait nager à 20 ans. Aujourd'hui, elle s'occupe de sa mère malade.*

### ? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Comportements antérieurs : natation, expériences positives
- Bénéfices perçus et obstacles perçus (temps, coût, douleur au genou)
- Auto-efficacité : se sent-elle capable ?
- Influences interpersonnelles : amie, famille ; influences situationnelles : piscine, horaires
- Exigences concurrentes : rôle d'aidante, travail



D ♣

♣ TRÈFLE · ANALYSER LA SITUATION

## Nola Pender

Promotion de la santé · 1982

**Situation :** Mme P., 50 ans, sédentaire, prédiabétique, voudrait « se remettre au sport » sans y parvenir.

> *« Je n'y arriverai pas, je n'ai jamais le temps. »*

### ? Comment formulez-vous la situation selon Pender ?

REPÈRES ATTENDUS

- Auto-efficacité faible ; obstacles perçus supérieurs aux bénéfices
- Exigences concurrentes fortes qui empêchent l'engagement
- Leviers : affect positif lié à la natation, soutien possible d'une amie
- Pas encore d'engagement dans un plan d'action précis



D ♠

♠ PIQUE · INTERVENIR & ÉVALUER

## Nola Pender

Promotion de la santé · 1982

**Situation :** Mme P., 50 ans, sédentaire, prédiabétique, voudrait « se remettre au sport » sans y parvenir.

> *Elle accepte d'essayer « un petit quelque chose ».*

### ? Quelles interventions et quels critères d'évaluation proposez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Objectifs modestes et atteignables pour vivre des réussites
- Plan d'action écrit : quoi, quand, où, avec qui
- Lever les obstacles : créneaux compatibles, relais pour sa mère
- S'appuyer sur le plaisir (natation) et sur le soutien de l'amie
- Évaluation : comportement adopté puis maintenu, auto-efficacité accrue

♥ ♦ ♣ ♠

**Théories de soins**

CAS CLINIQUES

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

**Théories de soins**

CAS CLINIQUES

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

**Théories de soins**

CAS CLINIQUES

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

**Théories de soins**

CAS CLINIQUES

IPA · Master

R ♥

♥ CŒUR · COMPRENDRE LA THÉORIE

## Katharine Kolcaba

Théorie du confort · années 1990

> *M. K., 72 ans, en hémodialyse trois fois par semaine, se plaint de crampes, de démangeaisons et de l'ennui des séances.*

### ? Quels sont les concepts clés de la théorie de Kolcaba ?

**REPÈRES ATTENDUS**

- Trois types de confort : soulagement, bien-être (tranquillité), transcendance
- Quatre contextes : physique, psychospirituel, socioculturel, environnemental
- Grille taxonomique de 12 cases pour repérer les besoins de confort
- Un confort accru favorise les comportements de santé



R ♥

R ♦

♦ CARREAU · RECUEILLIR AVEC LE MODÈLE

## Katharine Kolcaba

Théorie du confort · années 1990

**Situation :** M. K., 72 ans, en hémodialyse trois fois par semaine, se plaint de crampes, de démangeaisons et de l'ennui des séances.

> *Les séances durent 4 heures, dans une salle froide et bruyante.*

### ? Quelles données recueillez-vous ?

**REPÈRES ATTENDUS**

- Physique : crampes, prurit, fatigue, soif
- Psychospirituel : découragement, sens donné au traitement
- Socioculturel : famille, transports, lien avec l'équipe
- Environnemental : froid, bruit, position, durée des séances
- Mesure du confort (questionnaire général de confort)



R ♦

R ♣

♣ TRÈFLE · ANALYSER LA SITUATION

## Katharine Kolcaba

Théorie du confort · années 1990

**Situation :** M. K., 72 ans, en hémodialyse trois fois par semaine, se plaint de crampes, de démangeaisons et de l'ennui des séances.

> *Il envisage d'écourter ses séances.*

### ? Comment analysez-vous la situation avec la grille de Kolcaba ?

**REPÈRES ATTENDUS**

- Soulagement non atteint : prurit et crampes
- Bien-être compromis : ennui, froid, bruit
- Transcendance fragile : découragement, risque de renoncer au traitement
- Inconfort qui menace l'adhésion : priorité de soin



R ♣

R ♠

♠ PIQUE · INTERVENIR & ÉVALUER

## Katharine Kolcaba

Théorie du confort · années 1990

**Situation :** M. K., 72 ans, en hémodialyse trois fois par semaine, se plaint de crampes, de démangeaisons et de l'ennui des séances.

> *M. K. accepte d'en parler avec l'équipe de néphrologie.*

### ? Quelles interventions et quels critères d'évaluation proposez-vous ?

**REPÈRES ATTENDUS**

- Interventions techniques : réévaluer le poids sec et le bilan phosphocalcique avec le néphrologue
- Coaching : écoute, réassurance, information
- Réconfort : couverture, musique, activités pendant la séance
- Projets hors dialyse, lien avec les pairs
- Évaluation : confort mesuré, séances maintenues



R ♠

♥ ♦ ♣ ♠

**Théories de soins**

CAS CLINIQUES

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

**Théories de soins**

CAS CLINIQUES

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

**Théories de soins**

CAS CLINIQUES

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

**Théories de soins**

CAS CLINIQUES

IPA · Master

A ♥

♥ CŒUR · COMPRENDRE LA THÉORIE

## Afaf Meleis

Théorie des transitions · 2000-2010

> *M. T., 70 ans, diabétique, rentre à domicile après une amputation sous le genou. Il vit avec son épouse.*

### ? Quels sont les concepts clés de la théorie de Meleis ?

REPÈRES ATTENDUS

- Types de transition : développementale, situationnelle, santé-maladie, organisationnelle
- Propriétés : prise de conscience, engagement, changement, durée, points critiques
- Conditions facilitantes ou inhibantes : personnelles, communautaires, sociétales
- Indicateurs de processus et de résultat : maîtrise, identité reformulée



♥ A

A ♦

♦ CARREAU · RECUEILLIR AVEC LE MODÈLE

## Afaf Meleis

Théorie des transitions · 2000-2010

**Situation :** M. T., 70 ans, diabétique, rentre à domicile après une amputation sous le genou. Il vit avec son épouse.

> *Il dit : « Je remarcherai comme avant, c'est juste une question de temps. »*

### ? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Transitions en jeu : santé-maladie, situationnelle (épouse aidante), organisationnelle (hôpital-domicile)
- Prise de conscience et engagement dans la transition
- Significations et croyances, préparation, connaissances
- Ressources : logement, appareillage, rééducation, entourage



♦ A

A ♣

♣ TRÈFLE · ANALYSER LA SITUATION

## Afaf Meleis

Théorie des transitions · 2000-2010

**Situation :** M. T., 70 ans, diabétique, rentre à domicile après une amputation sous le genou. Il vit avec son épouse.

> *Le logement comporte un étage. Personne ne lui a parlé du délai d'appareillage.*

### ? Comment formulez-vous la situation selon Meleis ?

REPÈRES ATTENDUS

- Transitions multiples, simultanées et liées
- Conditions inhibantes : faible prise de conscience, logement inadapté, préparation insuffisante
- Points critiques prévisibles : premiers jours, appareillage, reprise de la marche
- Indicateurs de processus absents : il ne se sent ni connecté ni en confiance



♣ A

A ♠

♠ PIQUE · INTERVENIR & ÉVALUER

## Afaf Meleis

Théorie des transitions · 2000-2010

**Situation :** M. T., 70 ans, diabétique, rentre à domicile après une amputation sous le genou. Il vit avec son épouse.

> *La sortie est prévue dans 10 jours.*

### ? Quelles interventions et quels critères d'évaluation proposez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Préparer la sortie : information réaliste, étapes d'appareillage et de rééducation
- Supplémentation de rôle : préparer l'épouse à son nouveau rôle
- Aménagement du logement, coordination ville-hôpital
- Suivi rapproché aux points critiques
- Évaluation : maîtrise des nouvelles compétences, identité reformulée



♠ A

♥ ♦ ♣ ♠

**Théories de soins**

CAS CLINIQUES

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

**Théories de soins**

CAS CLINIQUES

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

**Théories de soins**

CAS CLINIQUES

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

**Théories de soins**

CAS CLINIQUES

IPA · Master

JOKER

JOKER 1

# Métaparadigme

Pour la théorie de votre choix, définissez les quatre concepts du métaparadigme : personne, santé, environnement, soin.

Si le groupe valide, ce joker remplace n'importe quelle carte manquante d'un carré.

JOKER

JOKER

JOKER 2

# Changement de lunettes

Relisez la situation de la dernière carte jouée avec une autre théorie du jeu. Qu'est-ce que cette autre lunette fait voir de nouveau ?

Si le groupe valide, ce joker remplace n'importe quelle carte manquante d'un carré.

JOKER

## Aide-mémoire · les couleurs

Chaque couleur est une étape du raisonnement.

**Cœur · Comprendre la théorie**
Auteure, concepts clés, vision du soin

**Carreau · Recueillir avec le modèle**
Ce que la théorie invite à observer chez la personne

**Trèfle · Analyser la situation**
Formuler la situation dans le langage de la théorie

**Pique · Intervenir & évaluer**
Interventions et critères d'évaluation issus du modèle

Un **carré** (les 4 couleurs d'une même valeur) = un raisonnement complet sur un même patient.

## Aide-mémoire · les théories

Chaque valeur suit un même patient à travers les 4 étapes.

| | |
|---|---|
| **7** | Hildegard Peplau · Relations interpersonnelles |
| **8** | Virginia Henderson · Les 14 besoins fondamentaux |
| **9** | Dorothea Orem · Déficit d'auto-soin |
| **10** | Callista Roy · Modèle de l'adaptation |
| **V** | Moyra Allen · Modèle de McGill |
| **D** | Nola Pender · Promotion de la santé |
| **R** | Katharine Kolcaba · Théorie du confort |
| **A** | Afaf Meleis · Théorie des transitions |

♥ ♦ ♣ ♠

**Théories de soins**

CAS CLINIQUES

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

**Théories de soins**

CAS CLINIQUES

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

**Théories de soins**

CAS CLINIQUES

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

**Théories de soins**

CAS CLINIQUES

IPA · Master